

İrritabl Bağırsak Sendromu

Rome IV temelli pozitif tanı, Bristol ile alt tip (IBS-C/D/M) ayrımı, alarm bulgularının taranması ve düşük FODMAP–lif–antispazmodik ekseninde dozlu tedavi ile izlem çerçevesi. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Rome IV

IBS-C / D / M

Düşük FODMAP

Alarm bulguları

01 Tanım ve ilk değerlendirme

İrritabl bağırsak sendromu (IBS), Rome IV kriterlerine göre tanı öncesi en az 2 ay boyunca ayda ≥ 4 gün görülen karın ağrısının aşağıdakilerden ≥ 1 'i ile ilişkili olmasıdır: dışkılama ile ilişki, dışkı sıklığında değişiklik veya dışkı kıvamında/görünümünde değişiklik. Ağrı, kabızlığın düzelmesiyle geçmemelidir (aksi halde fonksiyonel kabızlık düşünülür) ve uygun değerlendirme sonrası başka bir tıbbi durumla açıklanamamalıdır. Alt tip Bristol dışkı skalasındaki anormal dışkıların oranına göre belirlenir.

IBS-C — anormal dışkıların >25 'i Bristol 1–2 ve <25 'i Bristol 6–7

IBS-D — >25 'i Bristol 6–7 ve <25 'i Bristol 1–2

IBS-M — hem Bristol 1–2 hem 6–7 >25

IBS-U — hiçbir eşiği karşılamayan (sınıflanamayan)

Öyküde sorgula

- Ağrı paterni: lokalizasyon, dışkılama ile ilişki (öncesi/sonrası rahatlama), sıklık (ayda ≥ 4 gün, ≥ 2 ay)
- Bağırsak alışkanlığı: dışkı sıklığı ve Bristol kıvamı; alt tip (IBS-C/D/M) ve dalgalanma
- Eşlik eden: şişkinlik, gaz, aciliyet, tam boşalamama, mukuslu dışkı
- Diyet–semptom ilişkisi: laktoz, fruktoz, sorbitol, FODMAP yükü, kafein; beslenme günlüğü
- Tetikleyiciler: enfeksiyöz gastroenterit sonrası başlangıç (post-enfeksiyöz IBS), stres, uyku
- Psikososyal: anksiyete, depresyon, somatizasyon, okul devamsızlığı, yaşam kalitesi
- Aile öyküsü: IBD, çölyak, IBS; alarm bulgularının aktif ve yapılandırılmış taranması

Muayenede değerlendir

- Büyüme: boy-kilo persentilleri ve boy hızı; doğrusal büyümede duraklama alarmdır
- Karın: yaygın/değişken hassasiyet tipik; kitle, organomegali, lokalize hassasiyet patolojiktir
- Perianal/rektal: fissür, fistül, deri lezyonu, gizli kan (IBD lehine ipuçları)
- Ekstraintestinal: solukluk, aftöz lezyon, artrit, döküntü, çomak parmak, puberte evresi
- Genel: ateş, dehidratasyon, beslenme durumu; abdominal distansiyon
- Amaç: kapsamlı dışlama değil, alarm yokluğunda IBS'nin pozitif klinik tanısını desteklemek

Alarm bulgusu yoksa ve büyüme normalse IBS bir dışlama tanısı değil **pozitif klinik tanı** olarak konulmalıdır; geniş kapsamlı, invaziv tetkik rutin olarak gerekmez ve gereksiz tetkik semptom yükünü artırabilir.

02 Mekanizma temelli patofizyoloji

IBS tek nedenli değil; üst üste binen patofizyolojik yolların oluşturduğu bir bozulmuş beyin-bağırsak etkileşimidir. Baskın mekanizmayı öngörmek, hedefe yönelik tedavi seçimini (diyet, motilite düzenleyici, nöromodülatör) yönlendirir.

Visseral hipersensitivite

- Rektal/kolonik gerilme uyarısına artmış algı
- Ağrı ve aciliyet duygusunun santral amplifikasyonu
- Hedef: nöromodülatör, hipnoterapi, antispazmodik

Motilite bozukluğu

- Kolonik transit değişkenliği; hızlanma (IBS-D) veya yavaşlama (IBS-C)
- Postprandiyal aşırı gastrokolik yanıt
- Hedef: alt tipe göre laksatif/loperamid, antispazmodik

Beyin-bağırsak eksen

- Santral duyarlılaşma, otonom ve HPA eksen disregülasyonu
- Anksiyete/somatizasyon ile semptom şiddeti koreledir
- Hedef: BDT, gut yönelimli hipnoterapi, TCA

Mikrobiyota / post-enfeksiyöz

- Disbiyoz; akut gastroenterit sonrası post-enfeksiyöz IBS
- İnce bağırsak bakteriyel aşırı çoğalması örtüşmesi olabilir
- Hedef: probiyotik denemesi, diyet

Gıda / FODMAP / safra asidi

- Fermente edilebilir karbonhidratlarla (FODMAP) luminal distansiyon
- Bir alt grupta safra asidi malabsorpsiyonu (IBS-D)
- Hedef: düşük FODMAP eliminasyon-reintroduksiyon

Mukozal immün / genetik

- Düşük dereceli mukozal immün aktivasyon, mast hücre komşuluğu
- Mukozal geçirgenlik artışı; ailesel yatkınlık
- Semptom fenotipini ve süreğenliği etkiler

03 Karar akışı

Klinik değerlendirme sonrası ilk çatal alarm bulgusudur; ikinci çatal Rome IV uyumu ve sınırlı non-invaziv taramanın normalliğidir.

BAŞLANGIÇ

Kronik karın ağrısı + bağırsak alışkanlığı değişikliği

≥4 gün/ay ve ≥2 ay: dışkılama ile ilişkili ağrı, dışkı sıklığı ve/veya kıvamında değişiklik.

ADIM 1

Öykü + muayene + büyüme + Bristol ile alt tip

Diyet–semptom ilişkisi, post-enfeksiyöz başlangıç, psikososyal ve aile öyküsü; persentil ve boy hızı; IBS-C/D/M ayrımı.

KARAR 1

Alarm bulgusu var mı?

Kilo kaybı, büyüme duraklaması, GIS kanama, gece uyandıran ağrı/ishal, IBD/çölyak aile öyküsü, perianal hastalık.

EVET → Organik hastalığı dışla

HAYIR → Sınırlı non-invaziv değerlendirme

HEDEFLİ TETKİK

İleokolonoskopi ± üst endoskopi + biyopsi

IBD, çölyak, enfeksiyon ve eozinofilik hastalık için biyopsiler; klinikte görüntüleme (US/MR enterografi) ve hedefli laboratuvar.

BASAMAKLI TARAMA

İlk-basamak sınırlı test

Tam kan, CRP/sedim, çölyak serolojisi, fekal kalprotektin, gaita mikrobiyolojisi; alt tipe göre hedefli ekle.

KARAR 2

Rome IV karşılandı ve tarama normal mi?

Semptomlar başka bir durumla açıklanamıyor; kalprotektin ve çölyak serolojisi negatif.

EVET → Pozitif tanı

HAYIR → Yeniden değerlendir

TANI

IBS (alt tip: C / D / M)

İLERİ TETKİK

Endoskopi / hedefli inceleme

Biyopsikososyal açıklama ve güvence;
düşük FODMAP–lif–antispazmodik
ekseninde alt tipe yönelik tedavi, 4 haftalık
izlem.

Kalprotektin yüksek, seroloji pozitif veya
dirençli seyir: endoskopi + biyopsi ve
mekanizmaya yönelik ek değerlendirme.

Alarm bulgusu yoksa tetkik kademeli ve sınırlı tutulur; endoskopi/kolonoskopi seçilmiş (alarm, kalprotektin yüksekliği veya dirençli) olgulara ayrılır. Alt tip tetkik önceliğini belirler.

Alarm bulgusuz IBS'de kademeli değerlendirme		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Kan	Tam kan sayımı, CRP/ESR, çölyak serolojisi (anti-tTG IgA + total IgA), KCFT, üre/kreatinin	Anemi, inflamasyon ve çölyak taraması; hepsi normal düşer
Basamak 2 · Gaita	Fekal kalprotektin; gaita mikroskopisi/kültürü, Giardia antijeni	Kalprotektin <50 µg/g IBD dışlar; >250 µg/g end
IBS-D · hedefli	TSH, gerekiyorsa laktoz/fruktoz H2 nefes testi, seçili olguda safra asidi malabsorpsiyonu değerlendirmesi	Sekretuar/inflamatuar ishal ve karbonhidrat malabs
IBS-C · hedefli	Ayrıntılı kabızlık öyküsü; dirençli olguda TSH, çölyak, kalsiyum	Fonksiyonel kabızlık örtüşmesini ve sekonder nede
Basamak 3 · Görüntüleme	Batın ultrasonografisi	Lokalize ağrı/organomegali/kitle şüphesinde; rutin
Basamak 4 · Endoskopi	İleokolonoskopi + biyopsi ± üst GIS endoskopi	Alarm bulgusu, kalprotektin yüksekliği veya tedaviy mikroskobik kolit, çölyak, eozinofilik hastalık

Fekal kalprotektin IBS ile IBD ayrımında en yararlı non-invaziv testtir; kalıcı yükseklik (>250 µg/g) veya klinik alarm, IBS tanısını sorgulayıp endoskopiye gerektirir. Alarm yokluğunda çölyak serolojisi + kalprotektin normalse rutin endoskopiden kaçının.

Aşağıdakilerden herhangi biri IBS tanısını sorgulatır ve hedefli tetkik ile (çoğunlukla endoskopi/kolonoskopi) organik hastalık dışlamasını gerektirir.

- İstemsiz kilo kaybı

- Doğrusal büyümede duraklama / boy hızında yavaşlama

- GİS kanama: hematokezya, melena, gizli kan

- Gece uyandıran ağrı veya ishal

- İnatçı veya safralı kusma

- Kronik şiddetli / sekretuar ishal

- Disfaji / odinofaji

- Umbilikustan uzak, lokalize veya persistan ağrı

- Açıklanamayan ateş

- Perianal hastalık: fistül, fissür, deri lezyonu

- Artrit, aftöz stomatit, cilt bulguları, gecikmiş puberte

- IBD, çölyak veya peptik ülser aile öyküsü

- Anemi, hipoalbüminemi, yüksek inflamatuvar belirteç

Temel taş biyopsikososyal eğitim ve etkin güvencedir; diyet-yaşam düzenlemesi ile başlanır, farmakoterapi alt tipe ve baskın semptomu göre eklenir ve 4 haftalık deneme sonrası yanıt değerlendirilir. Çocukta düşük FODMAP diyeti diyetisyen eşliğinde, süreli (2–6 hafta eliminasyon + yapılandırılmış reintrodüksiyon) uygulanmalı; büyüme ve besin yeterliliği izlenmelidir.

Pediyatrik IBS'de basamaklı ve dozlu tedavi

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Eğitim + güvence (tüm hastalar)	—
Düşük FODMAP diyeti	2–6 hafta eliminasyon → yapılandırılmış reintrodüksiyon
Çözünür lif · Psyllium (ispaghula)	0,2 g/kg/gün (yaklaşık 5–10 g/gün), bölünmüş; bol su ile
PEG 3350 · makrogol (IBS-C)	İdame 0,4–0,8 g/kg/gün (gerekirse 1 g/kg/gün'e titre; m

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Nane yağı (enterik kaplı, IBS-ağrı/şişkinlik)	>8 yaş; <45 kg: 187 mg günde 3, ≥45 kg: 187–374 mg günde 3
Hiyosin butilbromür (antispazmodik)	6–12 yaş: 10 mg günde 3; >12 yaş: 10–20 mg günde 4
Mebeverin (antispazmodik)	>10 yaş / >30 kg: 135 mg günde 3, öğünden ~20 dk önce
Loperamid (IBS-D, seçili)	0,08–0,24 mg/kg/gün bölünmüş; maks 2 mg/doz (≤16 n
Probiyotik (adjuvan)	Lactobacillus rhamnosus GG 10 ⁹ –10 ¹⁰ CFU/gün veya l
Amitriptilin (dirençli, ağrı baskın)	10 mg gece ile başla; 0,2–0,5 mg/kg gece (maks ~25–5
Psikolojik tedavi	—

BASAMAK / İLAÇ	DOZ

Yaklaşım: Tek müdahaleyi 4 hafta dene; yanıt yoksa alt tipi ve baskın semptomu yeniden değerlendirip mekanizmaya göre değiştir (ör. IBS-C'de lif/PEG, IBS-D'de düşük FODMAP + loperamid, ağrı baskında nane yağı/antispazmodik → nöromodülatör). BDT ve hipnoterapi farmakoterapiye eşdeğer veya üstün kanıta sahiptir.

IBS kronik-dalgalanan bir seyir gösterir; hedef semptom kontrolü, işlevsellik (okul devamı) ve gereksiz tekrarlayan tetkikin önlenmesidir. Etkin iletişim ve güvence en tutarlı sonucu verir.

İzlem

- Pozitif tanıyı ve biyopsikososyal modeli güvence ile pekiştir; ailenin kaygısını doğrudan ele al
- Her müdahaleyi 4 haftada değerlendir; yanıt varsa sürdür, yoksa mekanizmaya göre değiştir
- Düşük FODMAP'ta reintrodüksiyonu tamamla; kalıcı gereksiz kısıtlamayı önle
- Büyüme eğrisini ve besin yeterliliğini her vizitte izle; yeni alarm bulgusunda yeniden değerlendir
- Semptom-diyet günlüğü; tetikleyici (FODMAP, laktoz, kafein, stres) yönetimini destekle

Dirençli olguda

- Alt tip ve baskın mekanizmayı yeniden gözden geçir; örtüşen fonksiyonel kabızlık/dispepsi ayır
- Komorbiditeleri ele al: anksiyete/depresyon, uyku bozukluğu, migren, otonom disfonksiyon
- Nöromodülatör (amitriptilin) ekle; psikolojik tedaviye (BDT, hipnoterapi) yönlendir
- Post-enfeksiyöz/İBAÇ örtüşmesini ve safra asidi malabsorpsiyonunu değerlendir
- Okul devamsızlığı ve aile beklentilerini yönet; multidisipliner destek kur

Farmakoterapi tek başına değil, diyet, davranışsal tedavi ve sürekli terapötik ilişki içeren biyopsikososyal plan içinde konumlandırılmalıdır; etkin güvence ve eğitim, alevlenme-remisyon döngüsünde en kalıcı yararı sağlar.

Kaynaklar

1. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, Shulman RJ, Staiano A, van Tilburg M. Functional Disorders: Children and Adolescents (Rome IV). Gastroenterology. 2016;150(6):1456-1468.

2. Rexwinkel R, Vlieger AM, Saps M, Tabbers MM, Benninga MA. A therapeutic guide on paediatric irritable bowel syndrome and functional abdominal pain-not otherwise specified. Eur J Pediatr. 2021;180(9):2839-2850.
3. Thapar N, Benninga MA, Crowell MD, et al. Paediatric functional abdominal pain disorders. Nat Rev Dis Primers. 2020;6:89.
4. Kline RM, Kline JJ, Di Palma J, Barbero GJ. Enteric-coated, pH-dependent peppermint oil capsules for the treatment of irritable bowel syndrome in children. J Pediatr. 2001;138(1):125-128.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulama koşullarının yerine geçmez. Dozlar hastaya, ağırlığa, komorbiditeye ve ilaç etkileşimlerine göre doğrulanmalıdır.